

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

CRUSCOTTO INDICATORI PATIENT SAFETY

Area 07 – Rischio Clinico

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MOD210_00	00	30/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
Risk Manager Clinico + RSGI	AD – Francesco Epifani	Riservato Alta Direzione + Direttore Sanitario	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo

Il presente modulo costituisce il cruscotto degli indicatori di Patient Safety di Toscana Diagnostica S.r.l. È in attuazione di ISO 7101:2023 §9.1 (Performance Evaluation) e del DM 11/01/2024.

Il cruscotto è aggiornato mensilmente dal Risk Manager Clinico, riesaminato trimestralmente dal Direttore Sanitario e portato in Riesame della Direzione semestrale.

2. KPI strutturali (struttura, processi, esiti)

2.1 KPI di struttura (input)

Indicatore	Formula	Target	Baseline 2026
% personale clinico formato su Patient Safety nell'anno	$(N \text{ formati}) / (N \text{ totali})$	≥ 95%	[da rilevare]
% procedure cliniche revisionate negli ultimi 24 mesi	$(N \text{ revisionate}) / (N \text{ totali})$	≥ 90%	[da rilevare]
Esistenza di Risk Manager Clinico designato	Booleano	Sì	Sì
Esistenza di Comitato per la Sicurezza dei Pazienti	Booleano	Sì entro 30/06/2026	Da costituire
% controlli HITL su sistemi AI (cfr. PRO085 / IDL034)	$(\text{Sistemi con HITL}) / (\text{Sistemi AI tot})$	100%	100%

2.2 KPI di processo (esecuzione)

Indicatore	Formula	Target	Frequenza
Tasso di segnalazione eventi avversi/1000 pazienti	$(N \text{ eventi MOD209}) \times 1000 / (N \text{ pazienti})$	Tracciato (sotto-segnalazione = rischio)	Mensile
% richieste con doppia identificazione paziente	$(\text{Richieste con 2-fattori}) / (\text{Tot richieste})$	100%	Mensile
Tasso di rifiuto campione	$(\text{Campioni rifiutati}) / (\text{Tot campioni})$	Tracciato (target settoriale: 1-3%)	Mensile
% referti consegnati entro tempi target (SLA TD)	$(\text{Referti in tempo}) / (\text{Tot referti})$	≥ 95%	Settimanale
% RCA completate entro le tempistiche	Cfr. PRO092	≥ 90%	Mensile
% CAPA chiuse entro la scadenza	$(\text{CAPA chiuse in tempo}) / (\text{CAPA totali})$	≥ 90%	Mensile

2.3 KPI di esito (outcome)

Indicatore	Formula	Target	Frequenza
Numero eventi sentinella/anno	Conteggio diretto	0 (target ideale; tolleranza 0 per ricorrenza identica)	Mensile
Numero adverse event con Severe Harm/anno	Conteggio diretto	Riduzione anno-su-anno	Mensile
Numero near miss riportati/anno	Conteggio diretto	Aumento atteso (cultura)	Mensile

Tasso di errore di laboratorio	(Errori) / (Tot esami)	segnalazione) ≤ 0,1% (industry benchmark)	Mensile
Tasso di errore di refertazione (errori riconosciuti post-consegna)	(Errori) / (Tot referti)	Tracciato + riduzione anno- su-anno	Trimestrale
Reclami paziente per Patient Safety	Conteggio diretto	Tracciato + riduzione anno- su-anno	Mensile
Patient Reported Outcome / NPS specifico safety	Survey ad hoc	Aumento anno- su-anno	Trimestrale

3. Cruscotto trimestrale - Stato Q2 2026

Tabella riassuntiva da compilare ogni trimestre. La presente è la baseline al lancio del cruscotto.

KPI	Q1 2026	Q2 2026	Q3 2026	Q4 2026	Trend	Status
Eventi sentinella	0				—	●
Adverse Event Severe Harm	0				—	●
Near miss riportati					—	—
Tasso errore laboratorio	%	%	%	%	—	—
% referti SLA	%	%	%	%	—	—
% RCA in tempo	%	%	%	%	—	—
% CAPA chiuse in tempo	%	%	%	%	—	—

4. Riesame del cruscotto

Il cruscotto è oggetto di:

- (a) riesame mensile da parte del Risk Manager Clinico (verifica trend, identificazione anomalie);
- (b) riesame trimestrale da parte del Direttore Sanitario (decisione su escalation, riallocazione risorse);
- (c) presentazione al Riesame della Direzione semestrale - input per il Patient Safety Plan annuale (TD-SGI-PLN005).

Variazioni significative dei KPI rispetto al baseline o al target attivano CAPA tramite la procedura SEA/RCA TD-SGI-PRO092.

5. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
00	30/04/2026	Prima emissione del documento	Risk Manager Clinico + RSGI	AD